Клинические рекомендации

Острый тонзиллит и фарингит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J02** — Острый фарингит **J02.0** — Стрептококковый фарингит **J02.8** — Острый фарингит, вызванный другими уточненными возбудителями **J02.9** — Острый фарингит неуточненный **J03** — Острый тонзиллит [ангина] **J03.0** — Стрептококковый тонзиллит **J03.8** — Острый тонзиллит, вызванный другими уточненными возбудителями **J03.9** — Острый тонзиллит неуточненный
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 31.10.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов; Международная общественная организация "Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням"; Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/306_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Главное 3

2. Клиника и классификация 3

2.1 Определение 3

2.2 Клиническая картина 3

2.3 Что важно для выбора тактики 3

2.4 Дифференциальная диагностика 4

3. Диагностика 4

3.1 Что не нужно рутинно 4

3.2 Шкала Центора — МакАйзека 5

3.3 Шкала FeverPAIN 5

4. Лечение 5

4.1 Антибиотики 5

4.2 Дозы внутрь 6

4.3 Парентерально 7

4.4 Симптоматическое лечение 8

5. Профилактика, госпитализация, осложнения 8

6. Источник и актуальность **9**

6.1 Неточности в самом тексте КР 9

1. Главное

- Чаще всего тонзиллофарингит вызывают вирусы, и антибиотик при нём не нужен. Из бактерий лечения требует только БГСА — бета-гемолитический стрептококк группы А; стафилококк, пневмококк и другие микробы в мазке из зева означают колонизацию.
- По клинике вирусный тонзиллофарингит от бактериального не отличить. Пациентам старше 3 лет делают экспресс-тест на БГСА; если у ребёнка он отрицательный, результат подтверждают посевом.
- Антибиотик назначают только при доказанной или очень вероятной стрептококковой природе. При вирусной инфекции он не помогает и не предотвращает присоединение бактерий.
- Препарат выбора — амоксициллин, курс 10 дней.
- Если через 48–72 часа приёма антибиотика улучшения нет, пересматривают диагноз: это может быть ОРВИ или инфекционный мононуклеоз.
- Рутинно не нужны СРБ, прокальцитонин, общий анализ крови в поликлинике, АСЛ-О и контрольный мазок после лечения.

2. Клиника и классификация

раздел 1 текста КР

2.1 Определение

Острый тонзиллофарингит — острое инфекционное воспаление слизистой оболочки и лимфоидной ткани ротоглотки: нёбных миндалин и фолликулов задней стенки глотки. Термин объединяет острый тонзиллит и острый фарингит, потому что чаще воспалены оба отдела.

По локализации различают тонзиллит, фарингит и тонзиллофарингит — по тому, какой отдел ротоглотки воспалён больше. По причине — стрептококковый и нестрептококковый (вирусный). Тактику определяет именно причина.

2.2 Клиническая картина

Болезнь начинается остро, обычно с температурой выше 38 °C (реже она нормальная или субфебрильная) и боли в горле, которая усиливается при глотании и может отдавать в ухо. Регионарные лимфоузлы бывают увеличены и болезненны, маленькие дети отказываются от еды. Состояние удовлетворительное или средней тяжести.

На стрептококк указывают увеличенные подчелюстные или переднешейные лимфоузлы, высокая температура, сильная боль в горле, «пылающий зев», налёт на миндалинах и отсутствие насморка, кашля и конъюнктивита.

На вирусную природу указывают насморк, конъюнктивит и кашель. При инфекции вирусом Эпштейна — Барр бывают генерализованное увеличение лимфоузлов, печени и селезёнки. Петехии на мягком нёбе встречаются и при стрептококке, и при вирусе Эпштейна — Барр.

При тонзиллофарингите миндалины увеличены симметрично, и этим он отличается от паратонзиллярного абсцесса.

2.3 Что важно для выбора тактики

Все штаммы БГСА чувствительны к пенициллину и всем бета-лактамам. К макролидам устойчив примерно каждый пятый штамм, к клиндамицину — 3–4%.

Если при клинике тонзиллофарингита из зева высевают *S. aureus*, *S. pneumoniae* или другие бактерии, это колонизация, и антибиотики не нужны.

2.4 Дифференциальная диагностика

Инфекционным мононуклеозом чаще болеют подростки и молодые взрослые до 30 лет. Характерны слабость, увеличение лимфоузлов, печени и селезёнки, атипичные мононуклеары в крови. Диагноз подтверждают ПЦР на ДНК вируса Эпштейна — Барр и IgM к капсидному антигену.

Синдромом «рука — нога — рот» болеют дети до 5 лет, обычно летом: во рту появляются пузырьки без налётов на миндалинах, а на кистях и стопах — сыпь.

При ангине Симановского — Плаута — Венсана на одной миндалине образуется некротическая язва с гнилостным запахом.

При дифтерии зева налёт плотный, снимается с трудом и оставляет кровоточащую поверхность.

Синдром Маршалла (PFAPA) — периодическая лихорадка до 39–40 °C с тонзиллитом или фарингитом, афтозным стоматитом и шейным лимфаденитом. Приступы повторяются каждые 1–2 месяца, средний возраст детей — 5 лет, приступ быстро снимают системные кортикостероиды.

---

3. Диагностика

раздел 2 текста КР
Диагноз ставят по жалобам на сильную боль в горле при глотании, по осмотру (гиперемия, инфильтрация и отёк миндалин, увеличенные регионарные лимфоузлы) и по результату экспресс-теста на БГСА или посева.

Каждого пациента должен осмотреть оториноларинголог, педиатр, врач общей практики или терапевт.

У каждого пациента нужно отличить стрептококковый тонзиллофарингит от вирусного.

Экспресс-тест на БГСА делают пациентам старше 3 лет. Если он положительный, посев не нужен. Если отрицательный, взрослому посев тоже не нужен, а у ребёнка и подростка результат подтверждают посевом.

Детям до 3 лет тест обычно не делают; исключение — когда стрептококковый тонзиллит есть у кого-то рядом, например у старшего брата или сестры.

Мазок из зева на стрептококк группы А сеют пациентам старше 3 лет, если экспресс-тест не делали или он отрицательный. Результат готов в течение 72 часов.

Мазок берут до начала антибиотиков, до утренней гигиены рта, натощак или через 2 часа после еды, под контролем орофарингоскопии, не касаясь зубов и языка, из устьев крипт миндалин и с задней стенки глотки.

3.1 Что не нужно рутинно

В поликлинике СРБ и прокальцитонин не помогают отличить вирусное воспаление от бактериального. СРБ определяют при госпитализации, прокальцитонин — у тяжёлых пациентов в стационаре.

Общий анализ крови в поликлинике делают только при необходимости, например чтобы исключить мононуклеоз.

АСЛ-О годится только для ретроспективной диагностики, потому что повышается лишь на 7–9-й день. Его определяют при подозрении на ревматическую лихорадку, гломерулонефрит или PANDAS.

Контрольный мазок на БГСА после лечения не нужен, если пациент не относится к группе высокого риска ревматической лихорадки и симптомы не повторяются.

У детей старше 3 лет обращают внимание на насморк, кашель, охриплость и конъюнктивит: при стрептококковой инфекции они бывают не больше чем у 10% и только при сопутствующей вирусной инфекции.

3.2 Шкала Центора — МакАйзека

Признак	Баллы
Температура тела выше 38 °C	1
Отёчность и гиперемия миндалин, налёты на задней стенке глотки и миндалинах	1
Нет катаральных явлений и кашля	1
Переднешейный и/или подчелюстной лимфаденит	1
Возраст 5–14 лет / 15–44 года / 45 лет и старше	1 / 0 / −1

Баллы	Вероятность БГСА: ≥15 лет / 3–14 лет	Тактика
0–1	7–12% / 8–14%	Нет показаний к посеву и/или антибиотикам
2–3	21–38% / 23–37%	Антибиотик — по экспресс-тесту и/или посеву
4 и более	57% / 55%	Антибиотик по клинической картине

3.3 Шкала FeverPAIN

Один балл дают за каждый признак: температура за последние сутки, налёт на миндалинах, обращение в первые 3 дня из-за сильных симптомов, выраженные гиперемия и отёк миндалин, отсутствие кашля и насморка.

При 0–2 баллах вероятность стрептококка групп A, C или G — 16%, при 3 баллах — 43%, при 4–5 баллах — 63%.

Шкалы помогают найти пациентов с высокой вероятностью стрептококковой инфекции, но диагноз с абсолютной точностью не ставят.

---

4. Лечение

раздел 3 текста КР

4.1 Антибиотики

При вирусной инфекции системные антибиотики не назначают: они не действуют и не предотвращают присоединение бактерий.

Назначать антибиотики при вирусном тонзиллофарингите «для профилактики» не рекомендуется.

Антибиотики назначают только при доказанной или очень вероятной стрептококковой природе.

При стрептококковом тонзиллите препарат выбора — амоксициллин.

При мононуклеозе может появиться сыпь на амоксициллин, но она бывает и от других антибиотиков, и без них, поэтому при мононуклеозе любых системных антибиотиков лучше избегать.

Пенициллины, цефалоспорины, линкозамиды и макролиды, кроме азитромицина, назначают на 10 дней.

При рецидивирующем стрептококковом тонзиллофарингите назначают амоксициллин с клавулановой кислотой или клиндамицин (детям старше 3 лет) на 10 дней. Пациента консультирует оториноларинголог, чтобы исключить хронический тонзиллит, а у детей — синдром PFAPA.

Если через 48–72 часа приёма антибиотика температура и боль не уменьшились, пересматривают диагноз: вероятнее всего, это ОРВИ или инфекционный мононуклеоз.

При нетяжёлой аллергии на пенициллины назначают цефалоспорины II–III поколения: цефуроксим, цефиксим, цефдиторен или цефподоксим. Перекрёстная аллергия с пенициллинами бывает меньше чем в 2% случаев для II поколения и меньше чем в 1% для III.

Уровни доказательности у этих препаратов в КР разные: у цефуроксима — УУР С, УДД 5; у цефиксима — С и 5 для детей, В и 1 для взрослых; у цефдиторена — С и 2; у цефподоксима — В и 2. Курс — 10 дней.

При аллергии на цефалоспорины или тяжёлой реакции на бета-лактамы (анафилактический шок, отёк гортани, тяжёлая крапивница) назначают макролиды или линкозамиды, помня об устойчивости стрептококка к макролидам.

Бензатина бензилпенициллин вводят однократно внутримышечно вместо курса таблеток, только если есть сомнения, что пациент будет их принимать. Детям с массой до 27 кг — 600 тысяч ЕД, больше 27 кг — 1,2 миллиона ЕД.

4.2 Дозы внутрь

Препарат	Взрослые	Дети
Стартовая терапия — 10 дней		
Амоксициллин[1]	1,5 г/сут в 3 приёма или 1,0 г/сут в 2 приёма	50 мг/кг/сут в 2–3 приёма
Альтернатива		
Бензатина бензилпенициллин[2] **в/м, однократно**	2,4 млн ЕД	менее 27 кг — 600 тыс. ЕД; более 27 кг — 1,2 млн ЕД
Цефалексин	старше 10 лет: 500–1000 мг/сут в 2 приёма	3–10 лет, только таблетки: 25–50 мг/кг/сут в 4 приёма, не более 1000 мг/сут
Рецидив и/или неэффективность амоксициллина		
Амоксициллин + клавулановая кислота[1] [3] **(во время еды)**	1750 мг/сут по амоксициллину в 2 приёма	50 мг/кг/сут по амоксициллину в 2–3 приёма
Нетяжёлая аллергия на пенициллины		
Цефуроксим (сразу после еды)	1,0 г/сут в 2 приёма	20 мг/кг/сут в 2 приёма
Цефиксим	400 мг/сут в 1–2 приёма	8 мг/кг/сут в 1–2 приёма
Цефдиторен (после еды)	400 мг/сут в 2 приёма	с 12 лет: 400 мг/сут в 2 приёма
Цефподоксим (во время еды)	200 мг/сут в 2 приёма	с 12 лет: 200 мг/сут в 2 приёма
Аллергия на цефалоспорины и/или тяжёлая реакция на пенициллины		
Кларитромицин	500–1000 мг/сут в 2 приёма	15 мг/кг/сут в 2 приёма

Препарат	Взрослые	Дети
Джозамицин (между едой)	1,0 г/сут в 2 приёма	40–50 мг/кг/сут в 2 приёма
Азитромицин (за 1 час до еды)	500 мг/сут в 1 приём, **3 дня**	20 мг/кг/сут в 1 приём, 3 дня
Мидекамицин (за 1 час до еды)	1,2 г/сут в 3 приёма	старше 3 лет: 50 мг/кг/сут в 2 приёма
Спирамицин	6 млн МЕ/сут в 2 приёма	старше 6 лет, более 20 кг: 300 тыс. МЕ/кг/сут в 2 приёма
Клиндамицин (запивать большим объёмом воды)	0,6 г/сут в 4 приёма	20 мг/кг/сут в 3 приёма

[1] С осторожностью при подозрении на инфекционный мононуклеоз. [2] Если пациент может не соблюдать назначения, при ревматической лихорадке у него или у родственников, при неблагоприятных бытовых условиях и вспышках в коллективе. [3] Клавулановой кислоты — не больше 10 мг/кг в сутки из-за риска диареи.

> Текст КР и таблица 1 расходятся. Цефуроксим взрослым: в тексте — 250 мг 2 раза в сутки, в таблице — 1,0 г в сутки. Амоксициллин с клавулановой кислотой детям: в тексте — 40 мг/кг в сутки, в таблице — 50 мг/кг. Амоксициллин детям: в тексте — 50 мг/кг в сутки в 2 приёма, не больше 1000 мг в сутки, в таблице — в 2–3 приёма без ограничения. Клиндамицин: в тексте взрослым 300 мг 2 раза в сутки, детям 3–12 лет 20–30 мг/кг в сутки, в таблице — 0,6 г в сутки в 4 приёма и 20 мг/кг. Выбор за врачом; проверьте дозы по инструкции в ГРЛС.

4.3 Парентерально

Если пациент не может или не хочет принимать препарат внутрь, его вводят парентерально до стабилизации, а затем переходят на приём внутрь.

Препарат	Дети	Взрослые
Ампициллин	до 1 года 100 мг/кг/сут; 1–4 года 100–150 мг/кг/сут; от 4 лет 1–2 г/сут; в 4 введения	и дети более 40 кг: 250–500 мг каждые 6 ч
Амоксициллин + клавулановая кислота в/в	90 мг/кг/сут в 3 введения	и дети старше 12 лет: 1,2 г каждые 8 ч
Ампициллин + сульбактам	до 12 лет или менее 40 кг: 150 мг/кг/сут в 3–4 введения	1,5–3 г каждые 6–8 ч
Цефазолин	1 мес — 18 лет: 25–50 мг/кг/сут (тяжёлые — 100) в 3–4 введения	2,0 г каждые 8 ч
Цефтриаксон	до 12 лет: 20–80 мг/кг/сут 1 раз (более 50 кг — до 2 г/сут)	и дети старше 12 лет: 2 г 1 раз в сутки
Цефотаксим	до 12 лет: 100–150 мг/кг/сут в 2–4 введения	и дети старше 12 лет или более 50 кг: 1–2 г каждые 6–8 ч
Клиндамицин (непереносимость β-лактамов)	20–40 мг/кг/сут в 3–4 введения	0,4–0,6 г каждые 6–8 ч

4.4 Симптоматическое лечение

При температуре и боли назначают ибупрофен, парацетамол или, старше 15 лет, ацетилсалициловую кислоту; детям — только парацетамол и ибупрофен. Здоровым детям старше 3 месяцев жаропонижающее дают при температуре выше 39,0 °C в прямой кишке или выше 38,5 °C в подмышке.

Ибупрофен взрослым — 200–400 мг, детям — 7,5 мг/кг, не больше 30 мг/кг в сутки. Парацетамол взрослым — 500–1000 мг, детям — 10–15 мг/кг каждые 6 часов, не больше 60 мг/кг в сутки.

Системные кортикостероиды при боли в горле рутинно не назначают.

Исключение — сильный дискомфорт и угроза асфиксии, например при мононуклеозе. Тогда однократно внутрь дают #дексаметазон 0,3 или 0,6 мг/кг или #преднизолон 1 мг/кг (УУР В, УДД 1).

При сильной боли назначают местные анестетики и НПВП в спреях, растворах и таблетках для рассасывания с учётом возраста. При стрептококковой инфекции местное лечение антибиотики не заменяет.

Бензидамин разрешён с 3 лет, бензокаин с хлоргексидином — старше 4 лет, флурбипрофен — старше 12 лет, кетопрофен — с 12 лет. Средства для горла вообще применяют с 3–4 лет из-за риска ларингоспазма. Миндалины не «смазывают» и налёт механически не снимают.

Дополнительно, в том числе курсами между рецидивами, можно применять растительные препараты: корень алтея, ромашку, тысячелистник, кору дуба, хвощ, листья грецкого ореха, одуванчик.

Пища должна быть щадящей и мягкой: не острой, не кислой, не солёной, не горячей и не холодной.

При неосложнённом тонзиллофарингите хирургическое лечение не рекомендуется.

5. Профилактика, госпитализация, осложнения

разделы 5–7 текста КР
После тесного бытового контакта со стрептококковой инфекцией антибиотики для профилактики назначают беременным со сроком 37 недель и больше, новорождённым и родильницам в первые 28 дней, а также людям 75 лет и старше.

Больных стрептококковым тонзиллофарингитом изолируют от организованных коллективов и ограничивают их контакты.

При рецидивирующем тонзиллофарингите для профилактики рецидивов назначают лизаты бактерий.

При рецидивирующем тонзиллофарингите применяют БАД с естественными бактериями ротоглотки, например *S. salivarius* K12.

После стрептококкового тонзиллофарингита пациента наблюдают месяц: общий анализ крови и мочи делают через 7–10 дней и через 3 недели, а при жалобах со стороны сердца — ЭКГ.

Лечат обычно амбулаторно. На антибиотиках улучшение наступает через 12–24 часа. В детский коллектив ребёнок возвращается после полного выздоровления.

В инфекционное отделение госпитализируют при тяжёлом состоянии и если из-за отказа от еды и питья нужна инфузионная терапия. При подозрении на гнойное осложнение, атипичной картине или необходимости операции пациента консультирует оториноларинголог и его госпитализируют в хирургическое отделение.

Стрептококковая инфекция даёт гнойные осложнения — паратонзиллярный, парафарингеальный, ретрофарингеальный абсцессы, гнойный лимфаденит — и негнойные: острую ревматическую лихорадку, ревматическую болезнь сердца, постстрептококковый гломерулонефрит, стрептококковый токсический шок, PANDAS.

6. Источник и актуальность

всегда полностью

Документ	Клинические рекомендации «Острый тонзиллит и фарингит (Острый тонзиллофарингит)»
Версия	3-я, опубликована в рубрикаторе 31.10.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР — не реже одного раза в три года: следующая ожидается не позднее октября 2027
Код в рубрикаторе	`306_3` · открыть текст КР ↗
Разработчики	Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов; Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням; Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности в самом тексте КР

- Дозы цефуроксима, амоксициллина, амоксициллина/клавуланата и клиндамицина в тексте и в таблице 1 различаются — подробно в блоке «Текст КР и таблица 1 расходятся» на вкладке «Лечение».
- В таблице 1 у бензатина бензилпенициллина в колонке «Дети» написано «у пациентов старше 12 лет при m<27 кг 600 тыс. ед» — по смыслу это дозировка по массе тела, как в тексте КР.
- Таблицы доз в PDF извлекаются вперемешку: все строки сверены по изображениям страниц 19–21.